UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Facultad de Ingeniería | Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática

FORMATO EGAP050 – SOLICITUD DE CAMBIO (EJEMPLO DESARROLLADO)

Asignatura / semestre	Ingeniería de Software II / 2026-II
Docente	Dr. Alfredo Daza Vergaray
Unidad / semana	Segunda unidad – Semana 7: Scrum – Cambio
Proyecto	PY-DR001 – Sistema web con Deep Learning para detección y clasificación de retinopatía diabética
Empresa cliente / desarrolladora	VisionSalud S.A.C. / DeepVision Solutions S.A.C. (ficticias)

1. Control e identificación

Código / versión	SC-001 / 1.0
Fecha / estado	26/10/2026 / Evaluada e incorporada al Product Backlog
Solicitante	Dr. Carlos Mendoza Ríos – Médico oftalmólogo (ficticio)
Responsable de evaluar	Victoria Campos – Product Owner (ficticio)
Épicas relacionadas	EP03 – Analizar retinopatía; EP04 – Visualizar resultados y explicabilidad
Historias relacionadas	HU08 – Visualizar grado predicho; HU09 – Guardar resultado

2. Descripción y justificación del cambio

Situación actual	El sistema muestra el grado de retinopatía predicho y permite guardar el resultado en la evaluación, pero no genera un documento descargable para la revisión clínica.
Cambio solicitado	Agregar la opción «Generar informe PDF» desde el detalle de la evaluación, con identificación del paciente, fecha, imagen de retina, clasificación estimada, confianza disponible y advertencia de uso como apoyo clínico.
Justificación / valor	Facilitar la revisión, documentación y comunicación del resultado dentro del flujo asistencial, evitando transcripciones manuales.
Alcance / exclusiones	Incluye generación y descarga del PDF para personal autorizado. No incluye envío automático por correo ni diagnóstico autónomo.

3. Análisis de impacto (estimación académica)

Alcance	Nueva funcionalidad de exportación, sin modificar el algoritmo de clasificación.
Tiempo / esfuerzo	Estimación inicial: 8 puntos de historia; requiere refinamiento con Developers. No compromete el Sprint en curso.
Costo	Sin compra prevista de licencias; esfuerzo interno por confirmar según capacidad del equipo.
Calidad / seguridad	Pruebas de contenido, legibilidad, descarga, permisos de acceso y protección de datos del paciente.
Riesgos	Exposición de datos sensibles en descargas; mitigación: autorización por rol, no incluir datos innecesarios y validar el archivo generado.
Dependencias	Requiere que HU08 y HU09 estén completadas y que el resultado de evaluación esté disponible.

4. Criterios de aceptación propuestos

- CA01. Solo usuarios autorizados pueden generar y descargar el informe.
- CA02. El PDF muestra paciente, fecha, imagen y grado predicho correspondientes a la evaluación seleccionada.
- CA03. El informe incluye la leyenda «Resultado de apoyo; no sustituye la valoración del médico».
- CA04. Si falta información obligatoria, el sistema muestra un mensaje claro y no genera un informe incompleto.
- CA05. Se verifica la correcta apertura del PDF y que no se mezclen datos entre pacientes.

5. Evaluación, decisión y seguimiento

Evaluación de Developers	Técnicamente viable; se propone implementar una plantilla PDF, validar permisos y añadir pruebas funcionales.
Decisión del Product Owner	Incorporar al Product Backlog como HU21 – Generar informe PDF de evaluación; prioridad media-alta, pendiente de ordenación final.
Planificación	Candidato para un Sprint futuro, sujeto a capacidad y prioridades. No se incorpora automáticamente al Sprint actual.
Responsables	Product Owner: ordenación del backlog; Developers: estimación e implementación; Scrum Master: facilitación.
Estado y evidencia	Solicitud evaluada; HU21 creada en backlog. Evidencia futura: captura de pantalla, PDF de prueba anonimizado y resultados de pruebas.

Nota académica: Caso y nombres ficticios. Las estimaciones y decisiones son ilustrativas; deben adaptarse a la evidencia real del proyecto. Scrum no exige un comité formal de control de cambios.